

TEMA 3.8 • UROLOGÍA

Incontinencia Urinaria: Clínica y Causas

PERFIL EUNACOM 4.01.1.025

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Definición y Generalidades

La **incontinencia urinaria** se define como la pérdida involuntaria de orina que es lo suficientemente grave como para afectar la calidad de vida o el bienestar social y psicológico de la paciente.

Es una condición significativamente más prevalente en **mujeres** que en hombres. Para el examen, es fundamental distinguir entre los dos tipos principales, ya que su enfrentamiento clínico y terapéutico es radicalmente distinto.

Tipos Principales de Incontinencia

Las causas más frecuentes son la **Incontinencia de Orina de Esfuerzo (IOE)** y la **Incontinencia de Orina de Urgencia (IOU)**.

TABLA 3.8.1: CARACTERÍSTICA VS INCONTINENCIA DE ESFUERZO (IOE)

CARACTERÍSTICA	INCONTINENCIA DE ESFUERZO (IOE)	INCONTINENCIA DE URGENCIA (IOU)
Mecanismo	Aumento de presión abdominal supera la resistencia uretral.	Contracciones involuntarias del músculo detrusor.
Desencadenante	Tos, estornudo, risa, ejercicio, levantar peso.	Deseo imperioso e incontrolable de orinar.
Volumen de pérdida	Pequeñas cantidades (gotas o chorro breve).	Grandes cantidades (vaciamiento importante).
Epidemiología	Más común en múltiparas y adultas mayores.	Causa más frecuente en mujeres jóvenes .
Hallazgo Urodinámico	Debilidad del piso pélvico (esfínter suele estar normal).	Vejiga inestable (contracciones no inhibidas).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, la clave para diferenciar ambas es el **volumen** y el **gatillante**: - Si pierde "un poquito" al toser = **Esfuerzo**. - Si siente ganas y "no alcanza a llegar" perdiendo mucho = **Urgencia**.

Diagnóstico y Estudio Urodinámico

Aunque el diagnóstico inicial es eminentemente **clínico**, en casos complejos o previo a cirugía se solicitan exámenes de **urodinamia** (manometría vesical y uretral).

- **Incontinencia de Esfuerzo**: El perfil uretral suele mostrar una debilidad del piso pélvico. Es importante notar que, frecuentemente, el esfínter vesicouretral en sí mismo no tiene alteraciones, sino que es el soporte del piso pélvico el que falla debido a traumatismos obstétricos (multiparidad).
- **Incontinencia de Urgencia**: La cistomanometría objetiva el **detrusor inestable** o **vejiga inestable**.

NOTA CLÍNICA

Vejiga inestable vs. Incontinencia de urgencia: La "incontinencia de urgencia" es el síntoma clínico (el escape). El "detrusor inestable" es el hallazgo técnico en la urodinamia (la presencia de contracciones no inhibidas del detrusor). Son dos formas de describir el mismo fenómeno desde ópticas distintas.

- **Incontinencia Mixta**: Muchos pacientes presentan síntomas de ambos tipos. El manejo en estos casos suele ser la combinación de los tratamientos para IOE e IOU.

Causas Secundarias y Otras Etiologías

Antes de diagnosticar una incontinencia primaria, es imperativo descartar causas reversibles o secundarias.

1. Infección del Tracto Urinario (ITU)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **primera medida** ante toda paciente con incontinencia urinaria es descartar una **Infección Urinaria**. La irritación vesical por infección puede simular perfectamente una incontinencia de urgencia.

2. Patologías Metabólicas

- **Diabetes Mellitus tipo 2 y Diabetes Insípida**: Causan poliuria (exceso de producción de orina), lo que puede sobrepasar los mecanismos de continencia.

3. Incontinencia por Rebalce (Paradojal)

Es característica de la **uropatía obstructiva baja** (ej. hiperplasia prostática en hombres o grandes prolapsos en mujeres). - La vejiga permanece llena (alto residuo post-miccional). - Al llenarse un poco más, la presión vence la resistencia y se produce un goteo por rebosamiento. - Se puede asociar a una "vejiga de lucha" con paredes hipertróficas que también genera síntomas de urgencia.

4. Vejiga Neurogénica

Se comporta de forma similar a la de rebalce, con escapes relacionados a un **alto residuo post-miccional** debido a la falta de coordinación neurológica para el vaciamiento.

5. Incontinencia Funcional

El sistema urinario está intacto, pero el paciente no puede llegar al baño por: - Deterioro cognitivo (demencia). - Limitaciones físicas (movilidad reducida).

6. Fístula Vésico-Vaginal

Comunicación anormal entre la vejiga y la vagina. - **Etiología**: Generalmente post-quirúrgica (secuela de histerectomía o cesárea) o congénita. - **Clínica**: **Goteo continuo** de orina a través de la vagina (no por el meato). - **Diagnóstico**: **Uretrocistografía** (permite visualizar el paso del medio de contraste hacia la vagina). - **Tratamiento**: Reparación quirúrgica.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el caso clínico menciona una paciente con cirugía ginecológica reciente que ahora tiene pérdida de orina **permanente y constante** (gota a gota), sospeche inmediatamente una fístula.

Resumen de Manejo Inicial

1. Historia clínica detallada (esfuerzo vs. urgencia). 2. Examen físico (evaluar prolapso, trofismo vaginal). 3. **Urocultivo** (siempre descartar ITU). 4. Diario miccional y, si es necesario, derivar para estudio de urodinamia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de cincuenta y dos años, mujer, con tres partos vaginales. Refiere pérdida involuntaria de orina en pequeñas cantidades cada vez que tose, estornuda o hace esfuerzo físico. No refiere urgencia miccional ni grandes pérdidas de orina. El sedimento de orina es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Incontinencia Urinaria: Clínica y Causas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La incontinencia de esfuerzo se caracteriza por pérdida de pequeñas cantidades de orina con el toser, estornudar o hacer fuerza; el factor de riesgo más importante es la multiparidad
- La incontinencia de urgencia se caracteriza por pérdida de grandes cantidades de orina precedida de deseo incontrolable de orinar; es la causa más frecuente en mujeres jóvenes
- La primera medida ante toda incontinencia urinaria es descartar infección urinaria activa como causa secundaria tratable con sedimento y urocultivo
- En la urodinamia, la incontinencia de esfuerzo muestra debilidad del piso pélvico; la incontinencia de urgencia muestra contracciones no inhibidas del detrusor que es lo que se llama vejiga inestable
- La incontinencia por rebose es característica de la uropatía obstructiva baja y de la vejiga neurogénica, ambas con alto residuo postmiccional
- La fístula vesico-vaginal, típicamente postquirúrgica tras histerectomía o cesárea, produce goteo urinario continuo; se diagnostica con uretrositografía y el tratamiento es quirúrgico
- La incontinencia mixta combina componentes de esfuerzo y urgencia; su manejo es la suma de los tratamientos de ambas formas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INCONTINENCIA URINARIA: CLÍNICA Y CAUSAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de cincuenta y dos años, mujer, con tres partos vaginales. Refiere pérdida involuntaria de orina en pequeñas cantidades cada vez que tose, estornuda o hace esfuerzo físico. No refiere urgencia miccional ni grandes pérdidas de orina. El sedimento de orina es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Incontinencia de urgencia por vejiga inestable
- B)** Incontinencia de esfuerzo por debilidad del piso pélvico
- C)** Incontinencia por rebose por uropatía obstructiva baja
- D)** Fístula vesico-vaginal por antecedente de partos
- E)** Infección urinaria recurrente como causa de la incontinencia

PREGUNTA 2

Paciente de treinta y dos años, mujer sin partos, consulta por pérdida involuntaria de grandes cantidades de orina. Refiere que le dan deseos urgentes e incontrolables de orinar y que no alcanza a llegar al baño a tiempo. En la cistomanometría se observan contracciones no inhibidas del detrusor. ¿Cuál es el diagnóstico correcto?

- A)** Incontinencia de esfuerzo con debilidad del esfínter uretral confirmada por cistomanometría
- B)** Incontinencia de urgencia con vejiga inestable confirmada por cistomanometría
- C)** Vejiga neurogénica con contracciones paradójicas del detrusor denervado
- D)** Incontinencia funcional por dificultad para llegar al baño a tiempo
- E)** Incontinencia por rebose secundaria a uropatía obstructiva baja

PREGUNTA 3

Paciente de cuarenta y cinco años, mujer, sometida a histerectomía total hace tres meses. Desde entonces presenta pérdida continua e involuntaria de orina en goteo, independiente de los esfuerzos o la urgencia. No tiene infección urinaria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cómo se confirma?

- A)** Incontinencia de esfuerzo post-cirugía; se confirma con perfil uretral en urodinamia
- B)** Incontinencia de urgencia post-cirugía; se confirma con cistomanometría
- C)** Fístula vesico-vaginal post-histerectomía; se confirma con uretrositografía
- D)** Infección urinaria recurrente post-cirugía; se confirma con urocultivo
- E)** Vejiga neurogénica por lesión del plexo pelviano durante la cirugía; se confirma con urodinamia

RESUMEN: INCONTINENCIA URINARIA: CLÍNICA Y CAUSAS

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina que afecta la calidad de vida del paciente y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Las dos causas principales que hay que diferenciar son la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, ambas con clínica distinta y manejo radicalmente diferente. La incontinencia de esfuerzo es más frecuente en mujeres multíparas y adultas mayores, siendo la multiparidad el principal factor de riesgo. Se caracteriza por escapes de pequeñas cantidades de orina ante esfuerzos como toser, estornudar, reírse o hacer fuerza física. La incontinencia de urgencia es la causa más frecuente en mujeres jóvenes y se manifiesta por escapes de grandes cantidades de orina precedidos de un deseo incontrolable de orinar sin tiempo para llegar al baño. Desde el punto de vista diagnóstico, el perfil uretral en la urodinamia de la incontinencia de esfuerzo muestra debilidad del piso pélvico, no del esfínter uretral propiamente tal. En la incontinencia de urgencia, la cistomanometría muestra contracciones no inhibidas del detrusor, lo que se llama vejiga inestable o detrusor inestable. Existen también las incontinencias mixtas que combinan ambos mecanismos y cuyo manejo es la suma de ambos tratamientos. La primera medida ante toda incontinencia urinaria es siempre descartar infección urinaria activa como causa secundaria tratable. Existen otras causas de incontinencia que hay que conocer. La incontinencia por rebose es característica de la uropatía obstructiva baja con alto residuo postmiccional. La vejiga neurogénica también produce incontinencia por rebose. La incontinencia funcional ocurre en pacientes con demencia o movilidad reducida que no alcanzan a llegar al baño. La diabetes mellitus y la diabetes insípida pueden producir poliuria e incontinencia secundaria. La fístula vesico-vaginal, típicamente postquirúrgica después de histerectomía o cesárea, produce goteo urinario continuo y se confirma con uretrositografía; el tratamiento es quirúrgico.